11.2 퇴원환자 의무기록 완결도 관리			
규 정 번 호	11.2	제 정 일	3주기 규정집 제정
관 련 인증기준	11.2 퇴원환자 의무기록 완결도 관리	최근 개정일	2025-10-15
담 당 부 서	원무과	시 행 일	2025-11-01
검 토 책 임 자	병원 운영위원회	검 토 주 기	2년
승 인 책 임 자	병원장	검토 예정일	2027-10-15
관 련 근 거	1. 의료법 제22조(진료기록부 등) 2. 의료법 시행규칙 제 14조(진료 기록부 등의 기재사항)		

▣ 목적 (Purpose)

의료기관은 진단과 치료과정의 기록 및 진료의 연속성을 증진시킬 수 있도록 퇴원환자의 의무기록을 충실하게 완결한다.

▣ 정책 (Policy)

1. 의학적 초기평가 기록을 작성한다.
2. 간호 초기평가 기록을 작성한다.
3. 경과기록을 작성한다.
4. 간호기록을 작성한다.
5. 퇴원요약을 작성한다.
6. 표준화된 진단코드를 사용한다.

▣ 지침 및 절차 (Guidelines & Process)

1. 의무기록의 완결도 관리

가. 의무기록 작성 공통 기준

1) 의무기록 작성은 병원에 등록된 정규서식(종이 및 전자기록)에 작성한다.
2) 의무기록은 환자의 인적사항과 병태의 변화, 치료내용, 검사 등 환자의 모든 정보를 정확하게 기록하여 진료의 과정이 의학적으로 타당하게 수행되었음을 증명하고, 환자의 경과 및 치료 결과를 확인할 수 있어야 한다. 질병명은 반드시 기재하여야 한다.
3) 기록에 사용하는 용어는 영어와 한글을 혼용하며, 사용 금지 약어 및 기호를 별도로 공지하여 사용하지 않도록 한다.

나. 필수 의무기록 종류별 주요 기재내용 및 작성 지침

1) 외래기록
   가) 주요내용: 초진기록/재진기록 등
   나) 작성지침
      (1) 진료 시 마다 해당 진료일 내에 작성한다.
      (2) 진료 시에 수행한 진료 내용을 빠짐없이 정확하게 작성한다.
2) 입원기록(Admission Note) - 의학적초기평가
   가) 주요내용: 환자이름, 환자 등록번호, 주호소, 현재 및 과거병력, 가족력, 신체검진, 초기검사, 추정진단, 작성자 서명 등

나) 작성지침

(1) 환자의 병력을 자세하게 기록하여 진단과 치료의 방향을 계획하고 추정진단을 이끌어내기 위한 사항을 기록으로서 입원 즉시 기록한다.

(2) 작성시한: 입원 후 24시간 이내에 기록한다.

3) 경과기록(Doctor's Progress note)

가) 환자이름, 환자 등록번호, 환자상태변화에 따른 치료계획 재수립, 임상경과, 치료나 처치 내용 및 이에 대한 반응, 결과, 합병증 혹은 부작용 유무 및 이에 대한 진단, 치료계획 등을 기록한다.

나) 작성 주기 : 월 2회 이상

4) 간호 초기평가

가) 내용 : 환자이름, 환자등록정보, 일반정보(성별, 나이 등), 입원정보(주호소, 입원동기, 입원경로 등), 환자 과거력 및 가족력, 최근 투약, 입원 및 수술경험, 문화적 종교적 특수성, 알레르기여부, 신체사정, 사회력, 작성자 서명 등

나) 작성 지침

(1) 환자의 입원정보, 기타 관련 사항을 자세하게 기록하여 간호 방향을 계획하기 위한 기록으로서 입원 즉시 기록한다.

(2) 작성시한 : 입원 후 24시간이내에 기록한다.

5) 간호기록

가) 환자이름, 환자등록번호, 환자상태변화에 따른 기록, 작성일, 작성자 서명 등 일련의 환자 상태변화를 기록 한다.

나) 작성주기 : 모든 근무 시 (Duty)

6) 퇴원요약(Doctor's Discharge Summary)

가) 주요내용: 퇴원 전 기록 작성여부, 환자이름, 환자 등록번호, 진단명, 치료 및 처치, 입원사유, 경과요약, 퇴원 시 환자상태, 추후관리계획, 작성자 서명 등

나) 작성지침

(1) 환자 퇴원 시점에 담당의사가 정확한 진단명 등을 기록하고 검토한다.

(2) 퇴원요약은 환자 퇴원 전까지 기록해야 한다.

(3) 예고 없이 퇴원(사망환자, 응급상황 발생 등), 입원 당일 퇴원하는 환자 등 예기치 않은 퇴원의 경우 퇴원 전까지 작성을 유예할 수 있다.(퇴원 후 지체 없이 작성한다)

7) 전과기록(Transfer In/Out Note)

가) 주요내용 : 환자의 기본 정보 및 병력, 전과의 이유가 되는 임상적 소견 및 근거, 전과시점 에서의 환자 상태 및 문제 목록, 향후 치료계획 등

나) 작성지침

(1) 환자의 병력을 자세하게 기록하여 진단과 치료의 방향을 계획하기 위한 의무기록으로 전과시 기록한다.

(2) 작성시한 : 전과 시점을 기준으로 전과 24시간 이전에 완성해야 한다.

8) 동의서(Informed Consent)

가) 규정 「5.5 동의서」에 따라 작성한다.

다. 의무기록 관리부서의 업무

1) 의무기록 관리
2) 미비기록 관리
가) 퇴원환자의 미비 의무기록은 퇴원 후 14일까지 완성하도록 한다.
나) 병원장에게 매월 미비율을 공지한다.

2. 표준화된 진단, 처치코드 사용

가. 주진단명 선정지침

1) 모든 환자에 대하여 하나의 주진단명을 선정하는 것을 원칙으로 한다.
2) 주진단이 여러 개인 경우 입원 시 상황, 진단적 검사, 치료 계획과의 밀접도를 고려하여 가장 중요한 상병을 주진단명으로 입력해야 한다.
3) 기존에 선정한 주진단명을 환자의 경과, 시행한 평가 및 검사결과를 바탕으로 변경할 수 있다.
4) 위의 일반지침에 부합하지 않는 경우 환자가 병원에 오게 된 이유 또는 주된 검사 및 치료가 제공된 상병을 주진단명으로 선정한다.

나. 주진단명 기재방법

1) 의무기록의 진단명 기재란 가장 상단에 주진단명을 기재하고 이어서 부진단을 작성한다.
2) 입원 중 주진단명이 변경된 경우 책임 의사는 진단명이 변경된 내용을 경과기록에 작성하여야 한다.
3) 의무기록에 사용되는 진단코드는 한국표준질병사인분류[KCD-9], 표준화된 수술 및 처치코드는 국제의료행위분류[ICD-9-CM, EDI-code]에 따른다.

▣ 부록 (Appendix)

1. 퇴원환자 의무기록 현황
2. 미비차트 의사별 발생률 및 완결률, 월별 발생률 및 완결률

▣ 규정 개정일 [누적]

2025년 10월 15일 개정하고 2025년 11월 1일 시행한다.

승 인 책 임 자	병 원 장	이름		서명	
승 인 일	. . .				

부록1. 퇴원환자 의무기록 현황

퇴원환자 의무기록 완결도

※결과표시 : Y (예) / N (아니오) / NA (미해당)

구분	내 용	순번	의무기록1	의무기록2	의무기록3	의무기록4
		등록번호				
		환자명				
		퇴원일				
		주치의				
의학적초기평가	**24시간 이내 기록 작성 여부**					
	환자이름					
	환자 등록번호					
	입원 시 진료과					
	주호소					
	병력					
	가족력					
	신체검진					
	추정진단					
	작성자 서명					
경과기록	환자이름					
	환자 등록번호					
	주요 환자 상태 변화					
	작성자 서명					
간호초기평가	24시간 이내 기록 작성 여부					
	환자이름					
	환자 등록번호					
	일반정보(성별, 나이 등)					
	입원정보(주호소, 입원동기, 입원경로 등)					
	병력					
	가족력					
	최근 투약력					
	입원 및 수술 경험					
	알러지여부					
	신체사정					
	문화적 종교적 특수성					
	작성자 서명					
간호기록	환자 이름					
	환자 등록번호					
	주요 환자 상태 변화에 따른 기록					
	작성자 서명					
퇴원요약	퇴원 전 기록 작성여부					
	환자이름					
	환자 등록번호					
	진단명					
	입원 사유					
	경과 요약					
	퇴원 시 환자상태					
	추후관리계획					
	작성자 서명					
주진단명에 대한 표준화된 진단코드 기록						
완결율						

부록2. 미비차트 의사별 발생률 및 완결율

미비차트 의사별 발생률 및 완결율 (20 년 월)

결재	담당	부서장	병원장

과 목	의 사	퇴원환자수	미비환자수	미비율	완결율
계					

미비차트 월별 발생률 및 완결율

퇴원년월	퇴원환자수	미비환자수	미비율	완결율	비 고
계					

1. 의사별 통계는 누적 관리한다.
2. 최종 결과를 매월 병원장에게 보고한다.
3. 미비차트는 의무기록 시한(14일)내 완결을 원칙으로 한다.